SNQ 公益服務類・複審簡報節錄

跨越言語的療癒

動物輔助治療融入末期病人身心靈舒緩之創新照護模式

財團法人大德安寧療護發展基金會
與臺北榮民總醫院合作

報告人：執行秘書　林明慧

CC BY NC ND



末期照護中的非語言陪伴與支持

病人虛弱、疼痛或難以言語表達時，情緒需求仍在~

動物輔助治療過程：治療犬的溫和陪伴，讓互動從撫觸、安靜共處開始；醫療團隊再依病況引導陪伴與情感表達、生命回顧，促進病人與家屬間之情感互動。

「在牠面前，父親才能安心地哭出來」

「透過牠，我們全家壓抑許久的悲傷，才終於有了共同的宣洩出口」



從試辦走向常態照護與世代交接

制度包含專責領犬員(Handler)、犬隻健康福利管理及臨床團隊權責分工。

105年
跨界試辦
定期進入病房/建立安全共識

108年
Oba 正式駐點
進入日常班表/流程訂立

114年10月
Olga 接續服務
退休與交接制度化

制度分工

基金會
公益治理與常態預算

醫院
臨床決策、感控與病安

犬訓單位
選訓與犬隻福利

創新特色：將動物輔助治療導入安寧病房常態照護流程，透過輔助治療犬穩定、溫和的陪伴，建立兼具情感連結、非藥物舒適照護與靈性支持的人本照護模式。

病人安全與犬隻福利的雙向防護

與高度虛弱、多重管路病人的床邊互動，同時注重病安、感染風險與犬隻負荷。
將設備、感控清潔與犬隻休息規則一併納入SOP



床邊專用階梯



值勤識別與感控



休息與活動空間

床邊介入前，臨床團隊評估病況與接受度；服務中持續監測病人及犬隻狀態。

動物輔助服務遵循六階段品質管理標準流程

醫療人員負責病人與介入目標；領犬員專責犬隻行為與福利。

01 意願確認
說明、同意與互動衛教

02 病人評估
感染、傷口、管路與接受度

03 犬隻評估
健康、清潔與行為狀態

04 環境安全
手部衛生、床面防護與動線

05 治療執行
醫療人員與領犬員雙軸監測

06 回饋紀錄
反應、事件與品質檢討改善

AAT 需有個別化目標、專業介入及結果紀錄

D1｜四類服務分類登錄完整性與一致性

PDCA指標	目標值	114年10月開始每季抽查
分類完整率	≧95%	114年Q4:75.1%； 115年Q1:98.0%；115年Q2:98.2%
紀錄一致性	≧95%	115年Q1:88.0% (44/50)；115年Q2:96.4% (53/55)

針對申請計畫書 頁12，29-30，35、表15。

Olga 臨床適應與低分場次改善成效

115年5–6月單次臨床評估 N=81；比較調整前 40 次、調整後 41 次

01 發現問題 Check

評分 ≤3 分，逐案檢討

壓力 / 迴避
夾尾、僵硬或異常喘氣

難以安定
反覆回望、遠離病人

界線與指令反應
非預期接觸、未依指令

02 具體調整 Act

當次處置

暫停互動、帶離休息，
降低要求；持續不安即中止

後續改善

縮短服務時間、控管人流;情境減敏及任務複訓

03 改善成效 Result

五構面平均得分

3.78–4.03 → 4.53–4.86

調整前　　調整後

各構面 1–3 分次數

8–11 次 → 0次

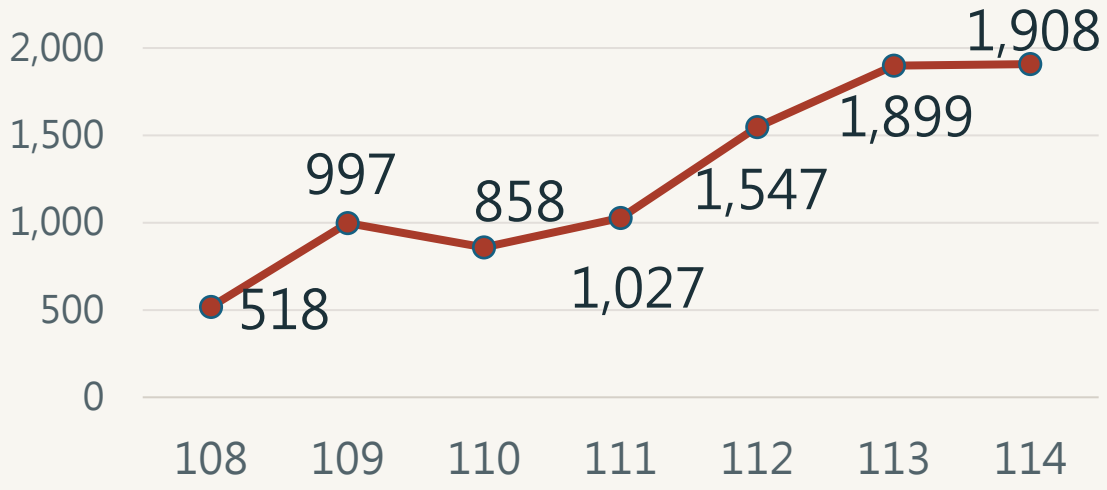
調整後 41 次評估之觀察結果

服務量與病家主觀回饋

病人與家屬直接服務

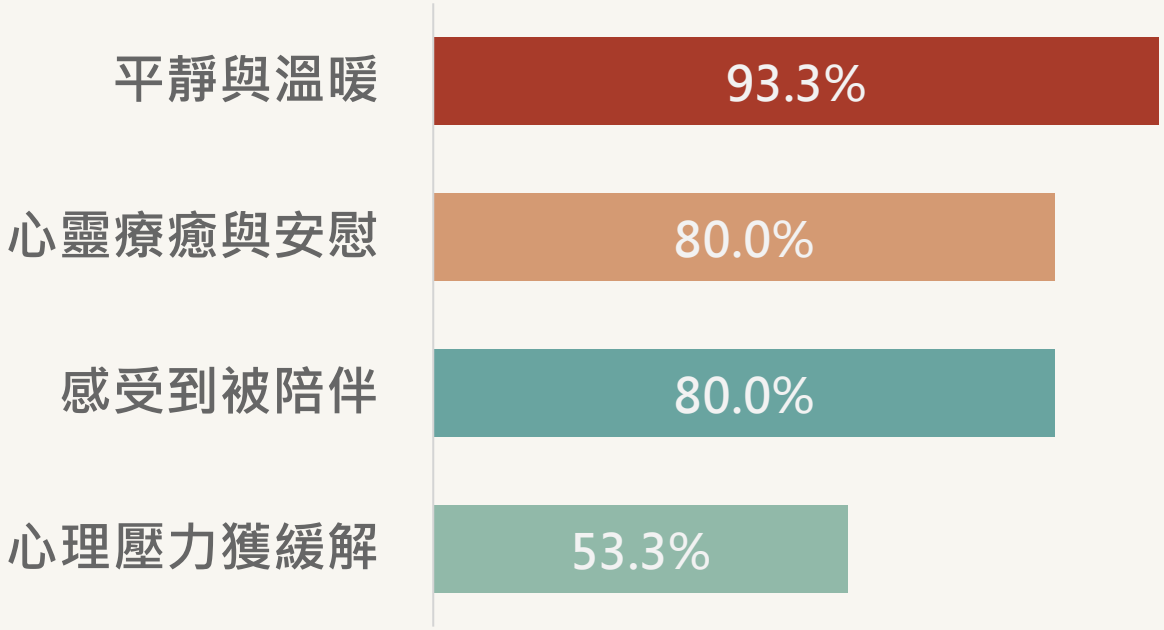
8,754 人次

108–114 年累計



Olga 接棒後初步回饋

115 年 7 月起，N=45 人次



人次可能重複計入。右側為自編問卷的主觀服務評值；樣本可能含家屬代答

依現有通報與紀錄，未發現相關重大事件

0 件

108–114年，8,754人次病家直接服務中：

未發現經判定與服務相關的交叉感染、咬抓傷、管路拉扯或跌倒通報。

113 / 114年流程指標

個案安全評估	100% / 100%
感控流程	100% / 100%
服務紀錄	93.5% / 95.6%

「沒有通報事件」不代表風險為零，仍需監測拒絕、取消與犬隻壓力中止。

AAT 納入非藥物處方常態轉介之評估與進展

目前人犬與跨場域排班量能有限，尚難支撐出院準備之常態轉介。
近期已有數例安寧居家訪視，先從個案經驗累積可行性與安全資料。

01 已有經驗

- 近期少數安寧居家訪視案例
- 由安寧病房、共照團隊提出
- 尚未形成固定排程

02 逐案評估

- 確認病家意願與犬隻狀況
- 評估感染、傷口、管路、居家動線
- 有個別介入目標才列 AAT

03 小規模試行紀錄成效

- 彙整案例，建立居家訪視檢核
- 記錄需求、承接及未承接原因
- 追蹤回饋、安全與犬隻福利

動物輔助治療AAT | 動物輔助活動AAA | 教學及團隊支持 | 公益推廣與社會倡議

跨院擴散與標準手冊

逾50家 醫療、長照及社區機構交流

擴散層級	代表性紀錄
理念與知識傳播	演講、研討與實務交流
臨床觀摩與能力建構	床邊教學、臨床觀摩
活動型服務導入	臺大、新店慈濟、臺中榮總、高雄榮總、淡水馬偕
駐點 / 部分制度採用	彰基兒童醫院、羅東聖母醫院

下一步:整理既有指引成可移轉的手冊

01 人員與犬隻梯隊

領犬員選訓、能力查核及備援；犬隻健康、休息與福利

02 臨床與感染管制

適應性評估、同意、衛生感控、床面與管路防護、異常通報

03 治理與品質紀錄

基金會與醫院權責、服務分類、紀錄、季檢討及事件追蹤

提供導入自評表、訓練清單與表單範本; 增設中小型與偏鄉醫院可採用的模組版本

總結：制度化、擴散力、全人永續經營

01 經評估與同意的AAT，納入安寧病房常規日常照護。

02 基金會公益治理、醫院臨床治理，並有犬訓單位提供專業支持。

03 完成Oba至Olga交接；已有跨院交流與部分導入，展現擴散力。



感謝委員聆聽與指教！！

備詢｜四類服務分流與臨床紀錄

114年起按目的與專業介入程度登錄

服務類別	納入條件 / 用途	紀錄重點
動物輔助治療 AAT	個別化照護目標、專業評估、明確介入與結果紀錄	照護目標、介入內容與結果
動物輔助活動 AAA	陪伴、互動與情緒支持，不設定個別化治療目標	互動對象、內容與當次反應
教學及團隊支持	臨床示範、教育訓練、團隊互動與工作支持	參與對象、人數、與場次
公益推廣與社會倡議	演講、媒體、社區活動、生命教育及跨機構交流	活動性質、合作單位與觸及人數

備詢｜服務定位與服務目標

臨床定位

經專業評估適合且病人或家屬同意後，將AAT納入安寧病房的日常全人照護。

病人	提升互動時的舒適感與情緒安定
家屬	提供低壓力的情緒表達與預期性哀傷支持
團隊	緩解工作壓力、提供情緒勞務職場支持
社會	外展活動提供臨床觀摩、活動型服務進行公益倡議

針對末期病人及主要照顧者的陪伴服務是核心對象；
團隊支持、人才培育與社會倡議是次級服務成果。

備詢｜服務合作架構與責任分工

大德基金會
公益治理

公益資源籌措與專案預算

人力支持與犬隻照護

教育推廣及計畫永續

共同協作
品質會議

共同擬定服務計畫

檢視服務量與流程完成率

追蹤犬隻福利及改善措施

臺北榮總
臨床治理

病人篩選與醫療決策

感染管制及臨床介入

異常通報與病人資料治理

犬訓單位　犬隻選訓、行為評估、領犬能力培育及犬隻福利專業諮詢

責任界線：病安、醫療決策及病人照護由臺北榮民總醫院負最終臨床責任；公益資源與永續推展由財團法人大德安寧療護發展基金會負最終治理責任。

備詢｜Olga 接棒後的適任性與低分改善前後比較

針對3分以下共11場次逐案進行低分改善措施、調整，增加休息與追蹤；
包含檢視疲勞、刺激、人流與互動時間；視情況縮短服務、漸進暴露與情境訓練等。

觀察重點	當次服務處置	後續改善調整及追蹤
A.壓力 / 迴避 **夾尾、躲避、僵硬、異常喘氣**	停止接近與合照，帶離休息；僵硬合併喘氣時結束當次服務	記錄情境與恢復時間；調整服務時長、人數及任務
B.難以安定 **反覆回望、起坐、遠離病人**	降低互動要求，允許犬隻選擇位置；持續不安即中止互動	調整領犬者站位與任務；追蹤提示及主動離開次數
C.非預期接觸 **舔人、管路或物品，嗅聞衣褲**	立即帶開並確認接觸部位	事前告知接觸界線，安排合照位置；逐件記錄接觸部位
D.指令 / 食物控制 **未依指令取食、只關注飼料**	領犬者統一給食；無法投入互動時停止增加任務	複訓時加強等待、離開食物及模擬病房情境；追蹤發生時機